

TEMA 7.14 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos Ansiosos: TOC, TEPT y Fobia Específica

PERFIL EUNACOM 1.13.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos ansiosos comprenden un espectro amplio de patologías que comparten la angustia como síntoma cardinal, pero difieren significativamente en su gatillante, su curso y su manejo específico. Es fundamental distinguir estas entidades de los trastornos de personalidad para un enfoque terapéutico correcto.

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

El **Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)** se define por la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, que consumen mucho tiempo y generan un malestar clínicamente significativo. Es vital no confundirlo con el **Trastorno de Personalidad Obsesivo-Compulsivo**, donde los rasgos son egosintónicos (la persona los ve como parte de su forma de ser y no le molestan).

Clínica del TOC

El cuadro se divide en dos componentes principales:

- **Obsesiones:** Son ideas, pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas, parasitarias y recurrentes. El paciente las reconoce como propias (no son impuestas externamente), pero le causan una gran ansiedad y angustia.
- **Compulsiones:** Son conductas (físicas) o actos mentales (repetir palabras, rezar, contar) que el individuo realiza como respuesta a una obsesión. Su objetivo es **disipar la ansiedad** o prevenir un evento temido.

NOTA CLÍNICA

Juicio de Realidad: A diferencia de los cuadros psicóticos como la **Esquizofrenia**, en el TOC el paciente mantiene el juicio de realidad. Entiende que sus pensamientos son irracionales o excesivos, aunque no pueda controlarlos. Si el paciente cree que sus pensamientos son reales (ej. "tengo un chip extraterrestre"), el diagnóstico vira hacia la psicosis.

Ejemplos Comunes en el Examen

TABLA 7.14.1: TIPO DE OBSESIÓN VS COMPULSIÓN ASOCIADA

TIPO DE OBSESIÓN	COMPULSIÓN ASOCIADA
Contaminación (gérmenes, suciedad)	Lavado de manos excesivo, uso de alcohol gel, limpieza de superficies.
Duda (¿cerré el gas?, ¿traje las llaves?)	Corroboración repetida (volver a casa 5 veces a revisar la cocina).
Daño o Mal Augurio (miedo a que alguien muera)	Rituales mentales, rezar, persignarse, realizar movimientos específicos.
Impulsos Agresivos/Inadecuados (miedo a empujar a alguien al metro)	Evitación (quedarse lejos de la orilla, no salir a la calle).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Una característica clave del TOC es que el paciente **habitualmente no hace crisis de pánico**. Esto ocurre porque la compulsión actúa como una válvula de escape que "alivia" la angustia antes de que escale a un ataque de pánico.

Tratamiento del TOC

Farmacológico: El pilar son los **Antidepresivos ISRS** (*Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina*). *Nota:* En el TOC se suelen requerir **dosis más altas** que en la depresión. **Psicoterapia:** Es fundamental (especialmente la terapia de exposición y prevención de respuesta), pero en el TOC **no es suficiente por sí**

sola; siempre debe acompañarse de fármacos.

Trastornos por Estrés: Agudo y Postraumático

Ambos cuadros surgen tras la exposición a un **evento traumático** (amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea sufrida o presenciada).

Clínica Compartida

Presentan cuatro pilares sintomáticos: 1. **Reexperimentación:** Recuerdos intrusivos, pesadillas recurrentes o flashbacks donde se revive el evento. 2. **Evitación:** Esfuerzos por evitar estímulos (lugares, personas, conversaciones) asociados al trauma. 3. **Hiperalerta (Hyperarousal):** Estado de sobresalto fácil, irritabilidad, dificultad para dormir o hipervigilancia. 4. **Embotamiento Afectivo:** Dificultad para expresar emociones, sensación de estar "congelado" o desconectado emocionalmente.

Diferencias por Tiempo de Evolución

La distinción entre ambos es estrictamente temporal, contando desde el momento del evento:

TABLA 7.14.2: DIAGNÓSTICO VS DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO	DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
Trastorno de Estrés Agudo (TEA)	Menos de 4 semanas (1 mes).
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)	Más de 4 semanas (1 mes).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Manejo del Estrés Agudo (TEA): Actualmente las **Benzodiacepinas están contraindicadas** en la fase aguda del trauma. Se ha visto que no previenen el TEPT e incluso podrían aumentar el riesgo de que el cuadro se cronifique. Si se requiere sedación o control de ansiedad, se prefieren antipsicóticos con perfil sedante como la Quetiapina u Olanzapina.

Tratamiento del TEPT

Tratamiento de base: ISRS (ej. Sertralina, Paroxetina). *

Tratamiento sintomático: Aquí sí se pueden usar Benzodiacepinas de forma controlada para crisis puntuales o insomnio.

Fobia Específica (Fobia Simple)

Es el miedo irracional y desproporcionado ante un objeto o situación específica.

Características Principales

- **Gatillante claro:** A diferencia del **Trastorno de Pánico**, donde las crisis son espontáneas, en la fobia la angustia aparece solo ante el estímulo (o su anticipación). - **Ansiedad Anticipatoria:** El paciente sufre días antes de enfrentarse al estímulo (ej. miedo a volar una semana antes del viaje). - **Conductas de Evitación:** El paciente altera su vida para no encontrarse con el objeto fóbico.

Tipos Frecuentes

- **Animales:** Arácnidos, serpientes, perros. - **Sangre-Inyecciones-Daño:** Es la única que suele cursar con una **respuesta vasovagal** (bradicardia y desmayo) en lugar de taquicardia. - **Situacionales:** Aviones (aerofobia), espacios cerrados (claustrofobia). - **Otros:** Alturas, tormentas, agujas.

Diagnóstico Diferencial

1. **Vs. TEPT:** En la fobia no hay reexperimentación (pesadillas o flashbacks del evento original). Si alguien le teme a los perros porque lo mordieron y tiene pesadillas con el ataque, es TEPT. Si solo le tiene miedo y lo evita, es fobia. 2. **Vs. Trastorno de Pánico:** En el pánico las crisis son "de la nada". En la fobia, si hay una crisis de pánico, es porque el estímulo está presente.

Tratamiento

El tratamiento de elección es la **Psicoterapia de tipo conductual**, específicamente la **desensibilización sistemática** o exposición progresiva. El objetivo es que el paciente logre tolerar la presencia del estímulo sin que este interfiera en su funcionalidad.

Resumen de Manejo Farmacológico

TABLA 7.14.3: PATOLOGÍA VS FÁRMACO DE ELECCIÓN		
PATOLOGÍA	FÁRMACO DE ELECCIÓN	CONSIDERACIÓN ESPECIAL
TOC	ISRS	Dosis altas + Psicoterapia obligatoria.
TEA	Antipsicóticos (Quetiapina)	Evitar Benzodiacepinas.
TEPT	ISRS	Manejo crónico similar a otros trastornos ansiosos.
Fobia Específica	Psicoterapia	Fármacos solo en casos muy puntuales (ej. BZD para un vuelo único).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda siempre el punto de corte de **4 semanas** para diferenciar el estrés agudo del postraumático. Es una pregunta clásica de tiempos.

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades | Fibrilación Auricular | Síndrome Coronario Agudo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 35 años lleva 2 años lavándose las manos más de 50 veces al día porque siente que siempre están contaminadas. Le arden las manos por el jabón. Reconoce que "es una exageración" pero no puede controlarlo. No hay pérdida del juicio de realidad. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Ansiosos: TOC, TEPT y Fobia Específica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TOC: obsesión (idea intrusiva que genera angustia) + compulsión (acción que disipa la angustia); no hay psicosis.
- El TOC requiere ISRS + psicoterapia; la psicoterapia sola es insuficiente, a diferencia de otros trastornos ansiosos.
- Estrés agudo vs TEPT: mismo cuadro clínico; el corte es 4 semanas desde el evento traumático.
- El estrés agudo NO se trata con benzodiacepinas (pueden favorecer la progresión a TEPT); se usan antipsicóticos atípicos.
- El TEPT puede debutar síntomas años después del evento traumático; el tiempo se cuenta desde el evento, no desde los síntomas.
- La compulsión no siempre se correlaciona lógicamente con la obsesión en el TOC (ej: rezar para que no mueran sus hijos).
- El TOC no hace crisis de pánico habitualmente porque la compulsión disipa la angustia antes de que alcance el nivel de crisis.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS ANSIOSOS: TOC, TEPT Y FOBIA ESPECÍFICA)**PREGUNTA 1**

Mujer de 35 años lleva 2 años lavándose las manos más de 50 veces al día porque siente que siempre están contaminadas. Le arden las manos por el jabón. Reconoce que "es una exageración" pero no puede controlarlo. No hay pérdida del juicio de realidad. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo; psicoterapia sin fármacos
- B)** Hipocondría; psicoterapia
- C)** TOC; ISRS + psicoterapia cognitivo-conductual
- D)** Trastorno de angustia generalizada; ISRS solo
- E)** Esquizofrenia simple; antipsicótico

PREGUNTA 2

Paramédico de 30 años atendió un accidente masivo hace 6 semanas con múltiples fallecidos. Desde entonces tiene pesadillas frecuentes con el evento, se sobresalta con cualquier sirena, evita ver noticias sobre accidentes y no ha podido retornar al trabajo. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Trastorno de estrés agudo; benzodicepinas
- B)** Trastorno de estrés postraumático; ISRS + psicoterapia
- C)** Depresión mayor reactiva; antidepresivos ISRS solo
- D)** Trastorno adaptativo ansioso; psicoterapia sin fármacos
- E)** Fobia simple a los accidentes; exposición progresiva

PREGUNTA 3

Paciente de 28 años refiere que tiene la idea recurrente de que podría empujar a alguien al metro al momento de pasar, lo que le genera mucha angustia. Por eso siempre espera alejado del andén y entra corriendo al último momento cuando llega el tren. Reconoce que "nunca haría eso". ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Esquizofrenia paranoide; antipsicóticos
- B)** Trastorno de personalidad antisocial; psicoterapia
- C)** TOC con obsesión de hacer daño; ISRS + psicoterapia
- D)** Fobia social por miedo al escrutinio en el metro
- E)** Trastorno de estrés agudo por miedo al metro

RESUMEN: TRASTORNOS ANSIOSOS: TOC, TEPT Y FOBIA ESPECÍFICA

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se define por la presencia de obsesiones (ideas intrusivas, parasitarias, repetitivas que causan ansiedad) y compulsiones (conductas que disipan la ansiedad). Las obsesiones más frecuentes son: contaminación (compulsión: lavarse las manos), duda (compulsión: corroborar), miedo a hacer algo malo y obsesiones de otro tipo. La compulsión no siempre se correlaciona lógicamente con la obsesión. El paciente con TOC no está psicótico: reconoce que la idea es parte de su pensamiento y que es irracional. El TOC habitualmente no hace crisis de pánico porque la compulsión disipa la ansiedad antes de que esta se desborde. El tratamiento requiere antidepresivos ISRS (a dosis habitualmente más altas que en depresión) más psicoterapia; la psicoterapia sola no es suficiente. El trastorno de estrés agudo (TEA) y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) comparten la misma clínica: evento traumático (amenaza a la integridad física), reexperimentación (flashbacks, pesadillas), embotamiento afectivo, hipervigilancia (sobresalto fácil) y evitación. La diferencia es el tiempo desde el evento: menos de 4 semanas desde el evento → estrés agudo; más de 4 semanas → TEPT. En el TEPT los síntomas pueden debutar años después del evento traumático. El tratamiento del estrés agudo NO es con benzodicepinas (pueden aumentar el riesgo de progresar a TEPT); se usan antipsicóticos atípicos (olanzapina, quetiapina). El TEPT se trata con ISRS + psicoterapia. La fobia específica o simple se diferencia del TEPT en que en la fobia hay miedo ante la exposición al estímulo, sin reexperimentación del evento. Se diferencia del trastorno de pánico en que en la fobia hay un gatillante claro mientras que en el pánico las crisis son espontáneas. La ansiedad anticipatoria puede aparecer en la fobia simple.